

ARTRITIS POR MICROCRISTALES

Ismael González Fernández, Alejandra López Robles, Julio Tito Camino Acha

INTRODUCCIÓN

Las artritis por microcristales son un conjunto de enfermedades producidas por el depósito de cristales de diferente composición química en las articulaciones y en los tejidos blandos. Son uno de los principales motivos de consulta en Urgencias debido al intenso dolor que generan; siendo su máximo representante, la gota.

DIAGNÓSTICO

Clasificación

- Gota: Por acúmulo de cristales de ácido úrico.
- Pseudogota/Condrocálcinosis: Por acumulo de cristales de pirofosfato cálcico.
- Artropatía por depósito de hidroxapatita cálcica.
- Artropatía por depósito de oxalato cálcico.
- Otras: Cristales de corticoides (tras infiltraciones); cristales lipídicos (en artritis reumatoide, espondiloartropatías) o cristales proteicos (en mieloma múltiple o crioglobulinemia)

Clínica

Lo más frecuente es que debuten en forma de monoartritis muy dolorosa (aunque pueden presentarse ya sea en debut o en evolución como oligo/poliartritis) de manera esporádica o tras un incidente intercurrente (como infecciones, traumatismos, cirugías, enfermedades...) en cualquier localización (aunque cada uno de los tipos tiene un lugar preferente de afectación). Pueden asociar febrícula o fiebre en alguna ocasión.

En casos de gota muy crónicos o en errores diagnósticos/terapéuticos podemos encontrarnos tofos (depósito de cristales de ácido úrico) en distintas localizaciones (tejidos blandos, cartílagos...), que en general, tienden a disminuir de tamaño con el tratamiento adecuado.

Pruebas complementarias

Ante toda monoartritis hemos de realizar punción y análisis del líquido sinovial, valorando aspecto macroscópico, bioquímica, recuento de fórmula leucocitaria y búsqueda de cristales. Es la artrocentesis la que nos dará en la mayoría de las ocasiones, el diagnóstico definitivo de esta entidad y poder diferenciar los grandes tipos en función del cristal que hallemos en el líquido sinovial.

- Artrocentesis.
- Hemograma.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, GOT, GPT, LDH, PCR, VSG. Ácido úrico.
- Coagulación básica.
- Rx de la articulación afecta dos proyecciones: AP-Lat.

A nivel analítico, suelen presentar elevación de reactantes de fase aguda (PCR/VSG) así como leucocitosis aunque no tan elevadas como las que esperaríamos encontrar en una artritis séptica. Es importante tener en cuenta que durante una crisis aguda de gota no tiene sentido medir los niveles de ácido úrico puesto que pueden estar normales.

En caso de realizar radiografías, se podría visualizar destrucción articular (mayor en gota) y

condrocalcinosis (más evidente en pseudogota).

Diagnóstico diferencial

	GOTA	Pseudogota	HA	OC
Cristal	Urato monosódico	Pirofosfato cálcico	Hidroxi. Cálcica	Oxalato Cálcico
Birrefringencia	Fuerte	Débil	-	Intensa
Forma	Aguja	Romboidal	Pequeño	Bipiramidal
Lugar preferente	1era MTF pie	Rodilla	Hombro	Cualquiera

HA: Hidroxiapatita cálcica; OC: Oxalato cálcico.

Criterios de ingreso

- Mal estado general del paciente.
- En caso de dudas diagnósticas.
- Refractariedad al tratamiento.

TRATAMIENTO

Gota

Durante el **ataque agudo**:

- AINE: Ibuprofeno 600 mg c/8 h; Naproxeno 500 mg c/12 h o Dexketoprofeno 25 mg c/8h.
- Colchicina: 1 mg/día durante 4 días. En la gota, se mantiene 6 meses.
- Corticoides: Pauta descendente durante 10 días (2,5-7,5 mg/día). Infiltraciones también son útiles.
- Tetracosáctido: Análogo de GH que estimula la producción endógena de corticoides. Se administraría 1 mg por vía IV (solamente uso hospitalario en casos refractarios).
- No iniciar tratamiento hipouricemiante hasta superar el ataque agudo.
- No suspender el tratamiento que el paciente tome de base.



Por otro lado, la hiperuricemia asintomática ($>6-7$ mg/dl ácido úrico) en principio no debe ser tratada. Sin embargo, EULAR/ACR recomiendan iniciar tratamiento si:

- Existen tofos.
- Hay afectación poliarticular o daño articular estructural.
- Enfermedad renal crónica (ERC).
- Pacientes muy jóvenes.

- Si la uricemia se mantiene elevada a lo largo del tiempo por el riesgo cardiovascular que implica.



Se utilizan sobre todo, inhibidores de la xantina oxidasa (disminuyendo así la producción endógena de ácido úrico) como son:

- **Alopurinol:** Iniciamos a dosis de 100 mg/día (excepto en ERC donde daremos 1 mg por ml/min de FG) hasta un máximo de 300 mg/día. Precaución en la combinación con diuréticos.
- **Fexobustat:** Iniciamos a dosis de 80 mg/día pudiendo elevarse hasta 120 mg/día. Contraindicado en cardiopatía isquémica.

Es importante que el tratamiento de base no sea suspendido durante los ingresos dado que puede incrementar el riesgo de sufrir un ataque agudo de gota. Al inicio del tratamiento podríamos administrar colchicina (1mg/día) a fin de prevenir ataques agudos de gota siempre que no existe ERC o enfermedad hepática severa.

Otras artritis por microcristales

Durante el ataque agudo: (Similar al de la gota)

- **AINE:** Ibuprofeno 600 mg c/8h; naproxeno 500 mg c/12h, indometacina 25-50 mg/día.
- **Colchicina:** Menos eficacia que en la gota. 1 mg/día.
- **Corticoides:** Pauta descendente. Podrían ser útiles las infiltraciones.



NOTA

- En general, las artritis por microcristales suelen presentarse como monoartritis muy dolorosas que requieren de artrocentesis e inicio de tratamiento antiinflamatorio de inmediato.

BIBLIOGRAFÍA

- Pascual Gomez, E. Artritis por microcristales. Epidemiología y patogenia. Tratado de Enfermedades Reumáticas de la SER. 2018. 94: 569-573.
- Pérez Ruiz, F. Gota. Tratado de Enfermedades Reumáticas de la SER. 2018. 95: 574-579.
- Andrés Collado, M. Enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato cálcico. Tratado de Enfermedades Reumáticas de la SER. 2018: 96: 580-583.
- Calvo Aranda, E. Enfermedad por depósito de hidroxipatita. Otras artritis por microcristales. Tratado de Enfermedades Reumáticas de la SER. 2018: 97: 584-587.